HÔPITAUX Paris

Saint Joseph — Marie Lannelongue

LIVRET D'ACCUEIL

TOME 2

LE SERVICE DES URGENCES



SERVICE DES URGENCES

SOMMAIRE

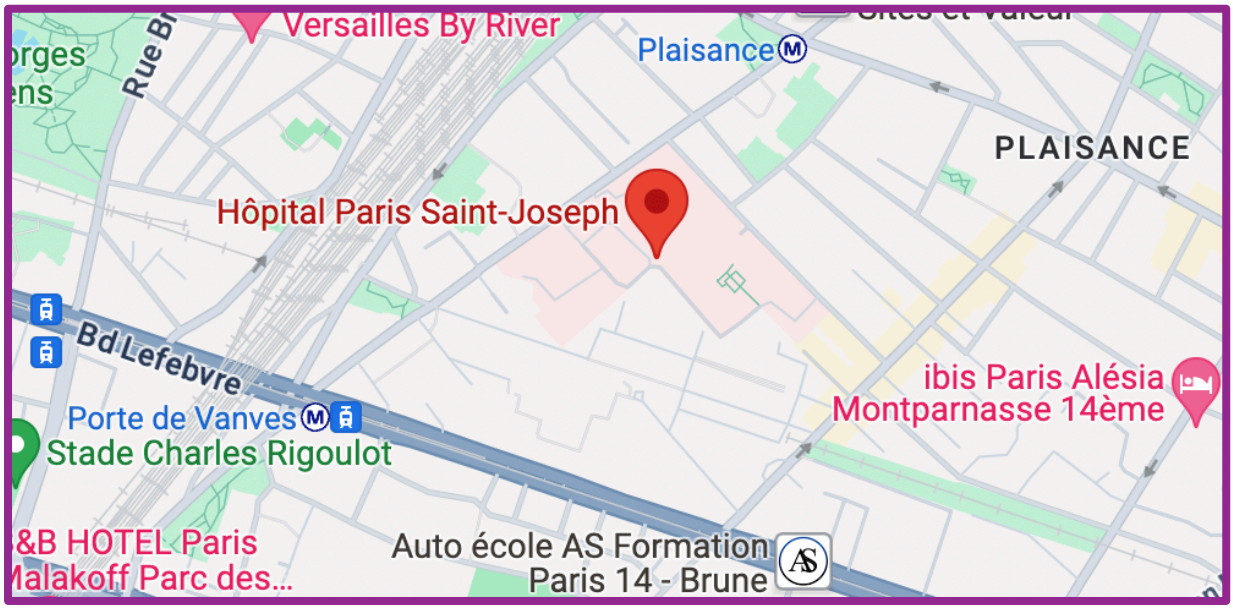
1. Présentation du service ..... - 3 -
Localisation et capacité d'accueil ..... - 3 -
Organigramme de l'équipe nagériale ..... - 4 -
L'équipe pluridisciplinaire ..... - 5 -
Répartition des effectifs ..... - 5 -
2. Organisation du service 6
3. Les zones du service 8
Accueil – IOA 8
Zone valide (zone 1) 9
Zone couchée (Zone 2) 10
SAUV : Salle d'Accueil des Urgences Vitales 12
Les Lits d'Urgences 13
4. Le parcours patient 14
5. IDE aux urgences 15
Rôle de l'infrimier aux urgences 15
Missions de l'infirmier aux urgences 15
Compétences et aptitudes 15
Un exemple de journée type aux urgences 16
Un exemple de journée type aux lits d'urgences 16

1. PRESENTATION DU SERVICE

LOCALISATION ET CAPACITE D'ACCUEIL

Notre service est situé au cœur de l'hôpital Paris Saint-Joseph et fait partie du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph – Marie Lannelongue (GHPSJ).

Nous nous situons dans le 14e arrondissement de Paris.

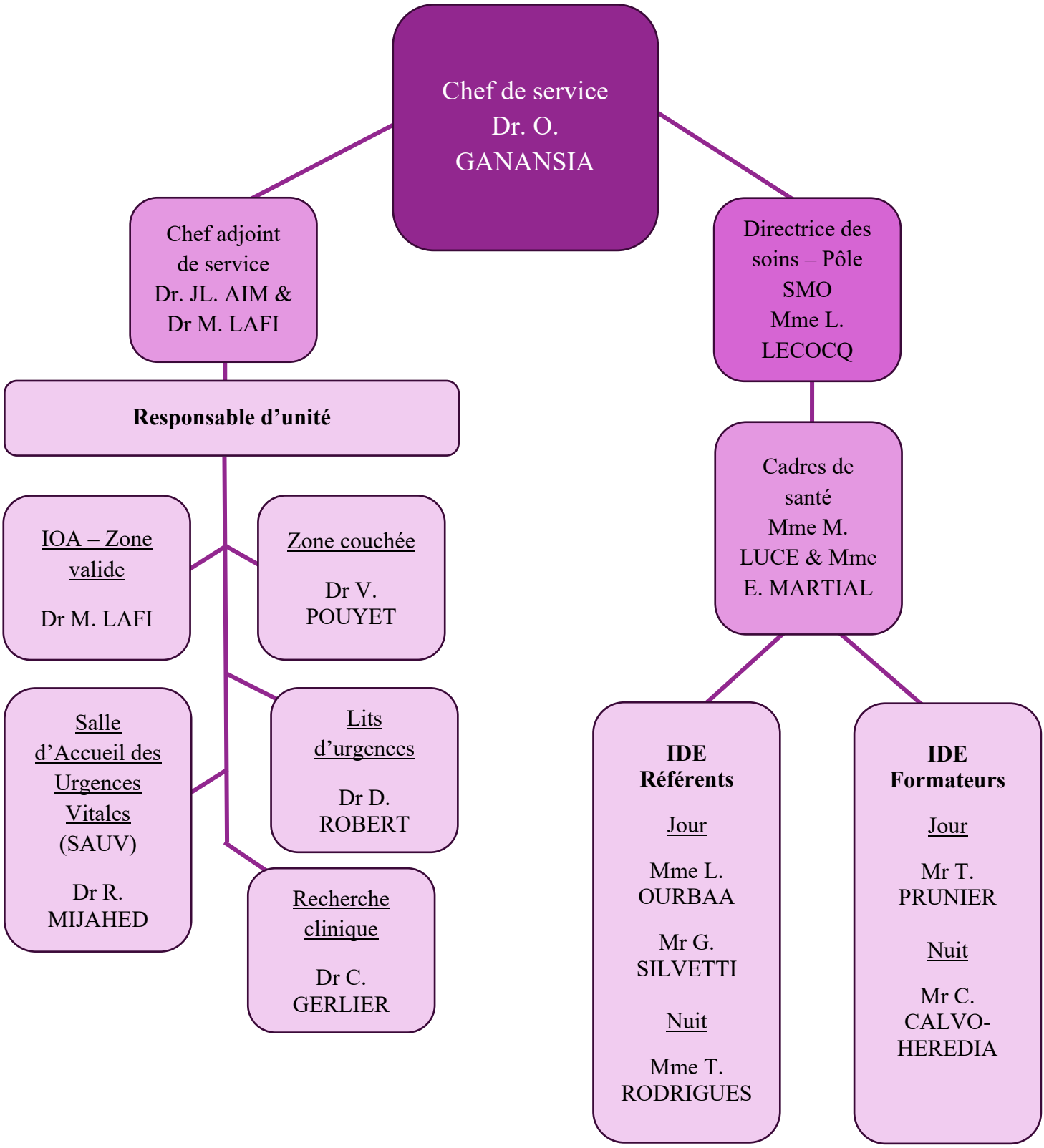


Le service est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous sommes des urgences générale et adulte, ce qui signifie que nous accueillons tous les patients à partir de l'âge de 16 ans (toutes les personnes n'ayant pas l'âge d'être pris en charge dans le service est quand même vu à l'accueil par une infirmière et un médecin, afin d'éliminer tous critère de gravité et de pouvoir réorienter le patient vers une structure adapté, centre de santé, urgence pédiatriques, …).
En 2024, le service a accueilli environ 65 000 passages, soit environ 10 passages par jour.

Comme tous les services d'urgences, le nôtre est divisé en plusieurs zones de soins, permettant des prises en charge adapté aux besoins des patients. Nous disposons également d'un service d'hospitalisation nommé « Lits d'urgences » ayant une capacité de 18 lits.



ORGANIGRAMME DE L'EQUIPE NAGERIALE



L'EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

L'équipe des urgences est composée de plusieurs acteurs, elle est donc dite pluridisciplinaire :

- Médecins
- Internes
- Externes
- Infirmière en pratique avancée, mention urgences (IPA-U).
- Infirmiers (IDE)
- Aides-Soignants (AS)
- Agents de service hospitaliers (ASH)
- Agents administratif (AMA)
- Secrétaire
- Une équipe de psychiatrie (un psychiatre et des infirmiers, rattaché au CHU Sainte-Anne, mais travaillant au sein du service des urgences).
- Assistante sociale
- Gestionnaire de lits

REPARTITION DES EFFECTIFS

JOUR	
SAU	**Lits d'urgences (UHCD)**
♦ 5 médecins + 4 internes + externes ♦ 9 IDE ♦ 2 IDE Référents ♦ 4 Aides-soignant(e)s ♦ 2 Agents des services hospitaliers (ASH)	♦ 2 Médecins ♦ 2 IDE ♦ 2 Aides-soignant(e)s ♦ 1 ASH
NUIT	
SAU	**Lits d'urgences (UHCD)**
♦ 3 médecins + 3 internes ♦ 6 IDE ♦ 1 IDE Référente ♦ 2 Aides-soignant(e)s ♦ 1 ASH	♦ 2 IDE ♦ 1 Aide-soignant(e)

2. ORGANISATION DU SERVICE

Les services d'urgences sont organisés en fonction des circulations et des flux de patients, afin de garantir à la fois la sécurité et la fonctionnalité de la prise en charge.

Ces principes sont :

- Les flux de patients suivent le principe de la « marche en avant », c'est-à-dire une circulation continue, avec un nombre limité de croisements et de reflux.
- Les patients valides (venus par leurs propres moyens) et les patients couchés (amenés par les secours) empruntent des circuits distincts jusqu'à leur rencontre avec l'infirmier organisateur de l'accueil (IOA).
- Après l'accueil et l'évaluation par l'IOA, les patients sont orientés vers une zone de soins en fonction de leur état de santé. Ces flux sont organisés et séparés dans la mesure du possible.
- Les zones de soins ne sont pas accessibles librement au public ni aux visiteurs. L'accès est soumis à autorisation et nécessite un accompagnement.
- L'accès à la Salle d'Accueil des Urgences Vitales (SAUV) est facilité pour garantir une prise en charge immédiate.

Par conséquent, un service d'urgences est réparti en zones fonctionnelles, organisées selon les besoins des patients et les circuits de prise en charge. Au sein de notre service, nous distinguons les zones suivantes :

- 2 salles d'attentes :
  - Une salle d'attente pour les patients valides.
  - Une salle d'attente pour les patients couchées.

- Zone d'accueil :
  - Accueil administratif
  - 3 boxes IOA (Infirmier organisateur de l'accueil).
  - 1 box MAO (Médecin d'accueil et d'orientation).

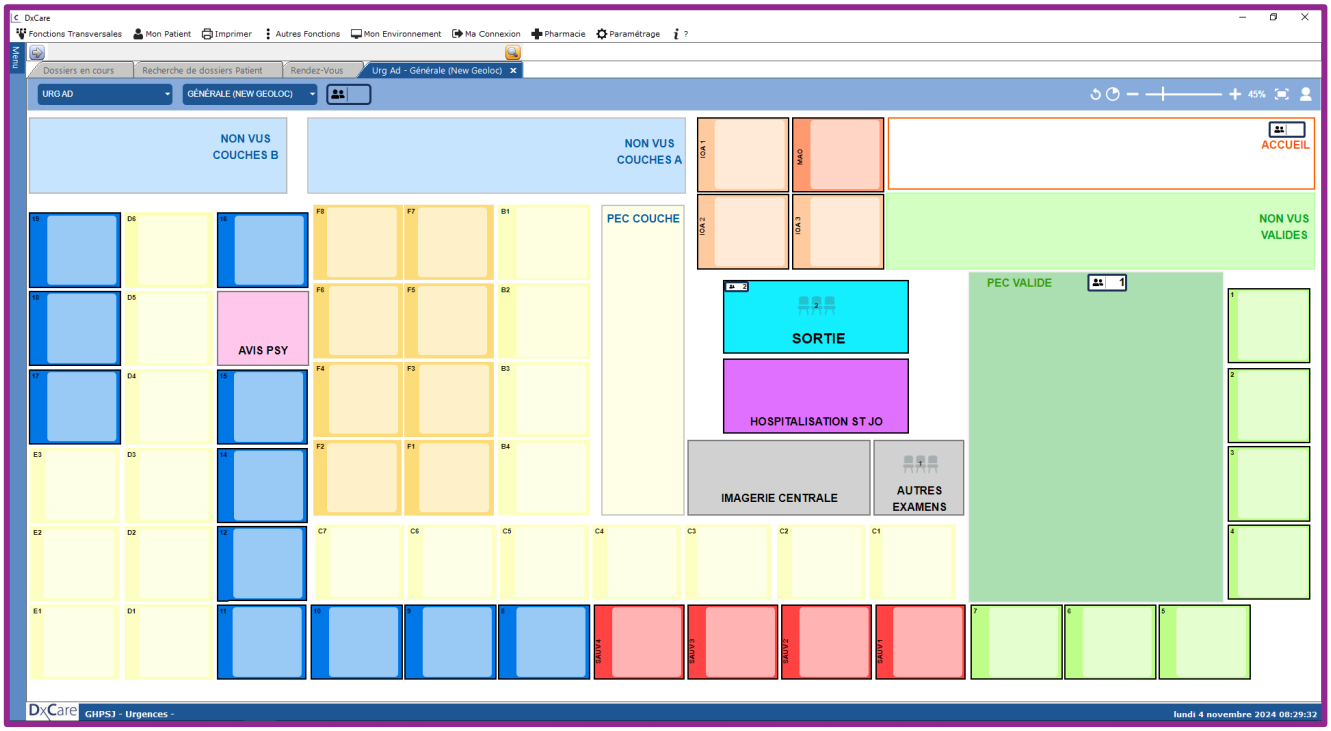
- Zone 1 – Zone valide :
  Cette zone est dédiée aux patients autonomes, pouvant se déplacer sans assistance.
  - 1 box de soins infirmiers.
  - 6 boxes de consultation médicale (dont 1 équipé pour la pose de plâtre).
  - 1 salle d'attente dédiée, appelée espace A.

- Zone 2 – Zone couchée :
  Réservée aux patients nécessitant une prise en charge allongée.
  - Divisée en deux sous-zones la journée en semaine :
    - Zone 2A
    - Zone 2B
  - 11 boxes de consultation médicale.

        - 6 boxes monitorés.
    - 27 places post-boxes :
        - Espace B : 4 places → patients alités, sans surveillance monitorée.
        - Espace C : 7 places → patients alités, sans surveillance monitorée.
        - Espace D : 5 places → patients verticalisés, sans surveillance monitorée.
        - Espace E : 3 places → patients alités, sans surveillance monitorée.
        - Espace F : 8 places → patients alités, avec surveillance monitorée.

- SAUV.
  *La SAUV est dédiée à la **prise en charge immédiate des urgences vitales**, nécessitant une évaluation et un traitement sans délai.*
    - **4 emplacements dédiés**
    - En cas de **suspicion de détresse respiratoire d'origine virale**, **le box 8 de la Zone 2** peut être utilisé en tant que **SAUV 5**, permettant une prise en charge isolée et sécurisée.

- Lits d'urgences
    - 18 lits d'hospitalisation
        - 16 chambre simple
        - 2 chambres double



3. LES ZONES DU SERVICE

ACCUEIL – IOA

Lorsqu'un patient se présente aux urgences de l'hôpital Paris Saint-Joseph, il entre dans la première phase de son parcours : la zone d'accueil.

1. Inscription administrative :

Dès son arrivée, le patient est accueilli par un agent administratif chargé de procéder à son enregistrement :

- Collecte de l'identité, de la carte Vitale, de la mutuelle, ou éventuellement des documents d'aide médicale.
- Création ou mise à jour du dossier administratif.
- Attribution d'une étiquette d'identification utilisée tout au long de sa prise en charge.

Cette étape est essentielle pour garantir la traçabilité du patient et préparer la suite du parcours de soins.

2. Passage par l'infirmier d'accueil et d'orientation :

Après l'inscription, le patient est pris en charge par l'IOA, un infirmier spécifiquement formé à l'évaluation initiale des urgences.

Ce professionnel a pour mission :

- D'assurer un entretien infirmier structuré (motif de recours, antécédents, signes cliniques).
- De prendre les constantes vitales si nécessaire (FR, SpO_2, TA, pouls, température…).
- D'identifier d'éventuels signes de gravité immédiate.

3. Tri et orientation :

Sur la base de cette première évaluation, l'IOA attribue un niveau de priorité selon une échelle de tri. Le patient est ensuite orienté vers la zone de soins la plus adaptée :

- Réorientation vers médecin généraliste en ville
- Zone valide si patient autonome avec pathologie non urgente.
- Zone couchée si patient non autonome ou nécessitant surveillance rapprochée.
- SAUV en cas d'urgence vitale.

Cette étape d'accueil et de tri permet :

- D'assurer une priorisation efficace des soins en fonction de la gravité.
- De fluidifier le parcours patient dans un contexte de forte affluence.
- De sécuriser la prise en charge dès l'entrée dans le service.

ZONE VALIDE (ZONE 1)

La zone Valide est dédiée à la prise en charge des patients autonomes à la marche, orientés ici par l'Infirmier Organisateur de l'Accueil (IOA) après une évaluation initiale.

Typologie des patients accueillis

- Patients classés **tri vert, bleu ou violet**.
- Motifs non graves, sans signe de détresse vitale.
- Patients **adressés par leur médecin traitant ou spécialiste pour un avis** (ex. : avis chirurgical).
- Cas de **consultation psychiatrique** en situation de crise sans danger immédiat.
- Pathologies telles que :
  - **Crise d'asthme modérée**
  - **Douleurs modérées** (céphalées, lombalgies…)
  - **Plaies ou traumatismes légers**
  - **Infections non compliquées**

Organisation des soins

- **Consultation médicale rapide** avec médecin urgentiste ou spécialiste ou IPA.
- Soins infirmiers (prise de constantes, prélèvements, administration de traitements, pose de voie veineuse périphérique, pansements, ...).
- Réalisation d'examens complémentaires (radiographie, ECG, …).

Objectifs

- **Fluidifier le flux patient**.
- Offrir une **prise en charge rapide, efficace et sécurisée** pour les urgences non graves.
- Favoriser un **retour à domicile** dans la majorité des cas.

ZONE COUCHEE (ZONE 2)

La zone Couchée accueille les patients en perte d'autonomie temporaire ou nécessitant une surveillance rapprochée, mais dont l'état ne relève pas d'une urgence vitale immédiate.

Typologie des patients accueillis

Patients classés tri **jaune**, **rose** ou **orange**, le plus souvent transportés par ambulance ou brancardés.

Motifs fréquents :

- Douleur thoracique, dyspnée modérée
- Malaise, troubles neurologiques isolés
- Fièvre élevée chez une personne âgée
- Suspicion d'infection sévère (ex. : pyélonéphrite, pneumonie)
- Déshydratation, vomissements, troubles digestifs importants

Organisation des soins

- Installation en box de soins avec monitoring si nécessaire.
- Consultation médicale approfondie.
- Surveillance infirmière régulière.
- Réalisation d'examens multiples (radio, scanner, bilan sanguin…).

Objectifs

- Offrir un cadre de soins adapté à une pathologie aiguë modérée ou instable.
- Permettre un diagnostic rapide et une orientation sécurisée.
- Réduire les risques de dégradation clinique en assurant une surveillance active.

ZONE 2A / ZONE 2B

Du lundi au vendredi, entre 9h et 18h, la zone couchée est scindée en deux sous-secteurs distincts afin d'optimiser la prise en charge et la répartition des flux selon le niveau de gravité des patients.

Zone 2A

- Prise en charge des patients monitorés, nécessitant une surveillance rapprochée (« **orange scopés** »).
- Patients suspectés d'occlusion intestinale.
- Accueil prioritaire des patients triés « **orange** ».
- Équipe dédiée : médecin, infirmiers, aides-soignants.

Zone 2B

- Accueil prioritaire des patients triés « rose » (tri ayant des motifs précis et/ou fast track personne âgée).
- Possibilité d'accueillir des tris jaunes en fonction de l'activité.
- Équipe dédiée : 1 médecin, 1 infirmier, 1 aide-soignant.

Objectif de cette sectorisation

Fluidifier la prise en charge médicale, en limitant les croisements de flux entre patients instables et stables.

SAUV : SALLE D'ACCUEIL DES URGENCES VITALES

La SAUV (ou salle de déchoquage) est une zone hautement spécialisée dédiée à la prise en charge immédiate des patients en détresse vitale ou à haut risque vital.

Typologie des patients accueillis

- Patients classés tri **rouge**.
- Transportés en priorité par le SAMU, les SMUR, ou les pompiers.
- Présentant plusieurs critères de gravités ou une défaillance multi organes.

Exemples de situations :

- Arrêt cardio-respiratoire
- Détresse respiratoire aiguë
- Accident vasculaire cérébral (AVC) suspecté
- Coma, convulsions prolongées
- Grave hémorragie, choc anaphylactique

Organisation des soins

- Zone hautement médicalisée et équipée (monitoring intensif, respirateurs, matériel de réanimation).
- Prise en charge par une équipe pluridisciplinaire spécialisée : médecins urgentistes, infirmiers et aides-soignants formés à l'urgence vitale.
- Stabilisation immédiate, puis orientation vers :
  - Bloc opératoire
  - Réanimation
  - USI (Unité de Soins Intensifs)
  - Zone couchée

Objectifs

- Assurer la survie du patient par des gestes techniques d'urgence.
- Limiter les séquelles grâce à une prise en charge précoce et structurée.
- Coordonner rapidement l'aval avec les unités de soins intensifs ou blocs opératoires.

LES LITS D'URGENCES

Les lits d'urgences (anciennement appelés « lits portes ») constituent une unité d'hospitalisation de courte durée, généralement limitée à 24 heures. Ils sont destinés à la surveillance, à l'observation ou à la poursuite des soins après une première prise en charge dans le service des urgences.

Cette zone fait le lien entre les secteurs d'accueil des urgences (valide, couchée, SAUV) et les unités d'hospitalisation classiques ou le retour à domicile.
Elle permet de :

- Prolonger la surveillance médicale et infirmière d'un patient instable ou non encore diagnostiqué.
- Finaliser un bilan médical qui ne peut être achevé en quelques heures.
- Optimiser la décision médicale (retour à domicile, hospitalisation conventionnelle, transfert).

Typologie des patients accueillis

- Patients nécessitant une observation clinique prolongée.
- Patients en attente de résultats d'examens différés (imagerie, biologie spécialisée).
- Patients en attente de place dans un service d'hospitalisation conventionnel.
- Situations médico-sociales complexes (ex. : personne âgée vivant seule, patient sans solution de sortie).
- Patients en fin de vie.

4. LE PARCOURS PATIENT

Afin de mieux comprendre l'organisation de notre service, il est essentiel de connaître le parcours type d'un patient aux urgences.

Tout commence par l'arrivée du patient dans les locaux et son passage à l'accueil administratif, qui constitue la première étape de son parcours. Cette inscription est réalisée par l'une des assistantes médico-administratives (AMA) du service. Elle permet de recueillir les informations essentielles à la prise en charge (vérification de l'identité, droits ouverts auprès de l'Assurance Maladie, mutuelle, etc.).

Il est important de noter que les patients peuvent arriver aux urgences par différents moyens :

- Par leurs propres moyens (à pied ou en véhicule personnel),
- Ou via les services de secours (ambulances privées, pompiers, Croix-Rouge, SAMU…).

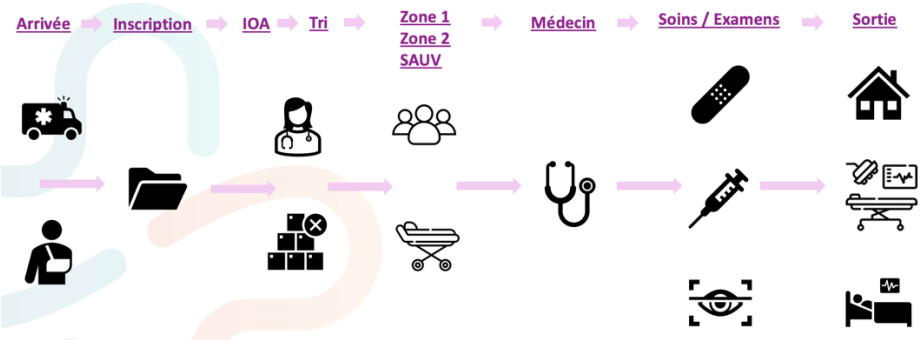
Une fois l'inscription administrative réalisée, le patient est pris en charge par un Infirmier Organisateur de l'Accueil (IOA). Ce dernier effectue un premier recueil infirmier structuré, évalue la situation clinique et les besoins immédiats du patient, et attribue un niveau de priorité (tri) à l'aide d'une grille de tri institutionnelle. Il oriente ensuite le patient vers la zone de soins la plus adaptée.

Selon cette orientation, le patient est installé dans un box, où il sera vu par un médecin pour l'examen clinique. Les soins et examens prescrits sont ensuite réalisés par l'infirmier(e).

À l'issue de cette phase, le patient peut être orienté vers l'un des espaces d'attente (A, B, C, D, E ou F), en attendant :

- Son retour à domicile,
- Son transfert vers un service d'hospitalisation,
- Ou sa prise en charge au bloc opératoire, selon les décisions médicales.

Ci-dessous, un schéma récapitulatif permet de visualiser ce parcours au sein du service.



5. IDE AUX URGENCES

ROLE DE L'INFRIMIER AUX URGENCES

L'IDE travaille sur l'ensemble des postes selon un planning pré établi : l'accueil et l'orientation, (au terme d'une expérience significative validée par l'encadrement du service), la zone 1, la zone 2, la Salle d'Accueil des Urgences Vitales (SAUV) et les lits portes.

L'IDE participe aux projets du service et s'implique dans une démarche de performance axée sur la qualité des soins, la bientraitance, la prise en charge de la douleur et la baisse des temps d'attente durant la prise en charge.

MISSIONS DE L'INFIRMIER AUX URGENCES

- Réalise les soins infirmiers selon les prescriptions, les protocoles établis et les **situations d'urgence**, en regard du projet du service dans l'**ensemble des zones de travail.**
- Respecte les protocoles du service et institutionnels (protocole de la prise en charge de la douleur, la transfusion, la gestion des stupéfiants, la prise en charge du mineur, la fugue…).
- **Accueille, oriente, effectue le tri selon le protocole établi et assure le lien avec le médecin régulateur.**
- Assure des transmissions orales et écrites efficaces auprès de l'équipe pluridisciplinaire et sur les documents de soins et lors des transferts dans les services si hospitalisation.
- Participe aux réunions du service avec l'ensemble de l'équipe et aux formations.
- **Contrôle le chariot d'urgences**, la fonctionnalité des appareils, la **fonctionnalité de la SAUV** et transmet tout dysfonctionnement sans délai.
- Assure le réassort des matériels de soins (chariot de soins, armoires …).
- Assure l'organisation des transferts et des sorties selon le poste occupé, collabore avec les AS pour l'installation.
- Participe à l'encadrement des étudiants.
- S'implique activement dans la prévention des risques professionnels.
- Respecte les protocoles d'hygiène, les mesures d'isolement, les protocoles de surveillance pour les patients sous contention.
- Participe à la préparation pré-op des patients allant au bloc opératoire.
- Participe à l'hygiène des locaux et des matériels.

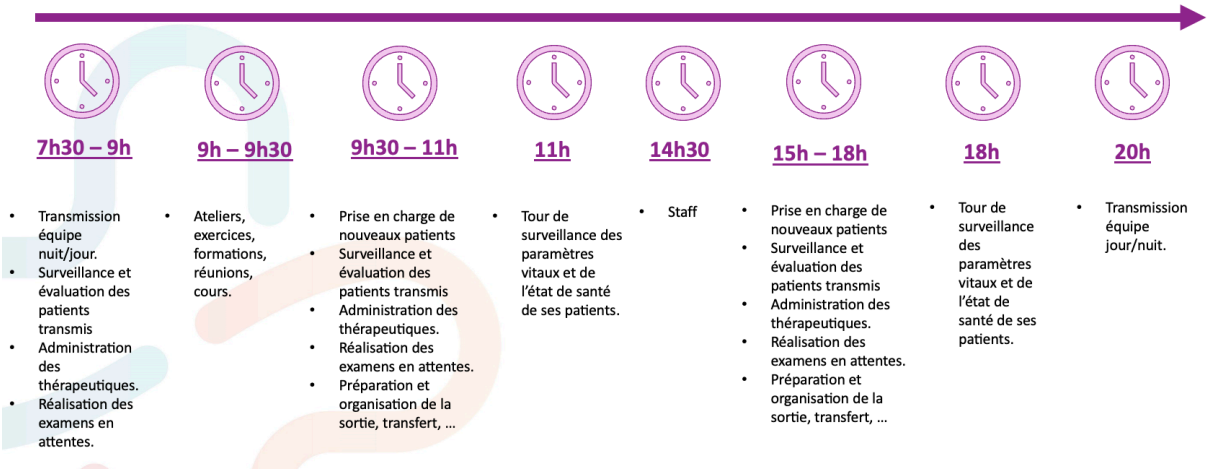
COMPETENCES ET APTITUDES

- Respect de la bientraitance.
- Gestion du stress.
- Esprit d'équipe, sens de la continuité, sens des responsabilités.
- Organisation, rigueur, discrétion, respect du secret professionnel.
- Maitrise de l'informatique (DxCare, DxPlanning, Théo, messagerie professionnelle, Paramedic, Pharma…).

UN EXEMPLE DE JOURNEE TYPE AUX URGENCES

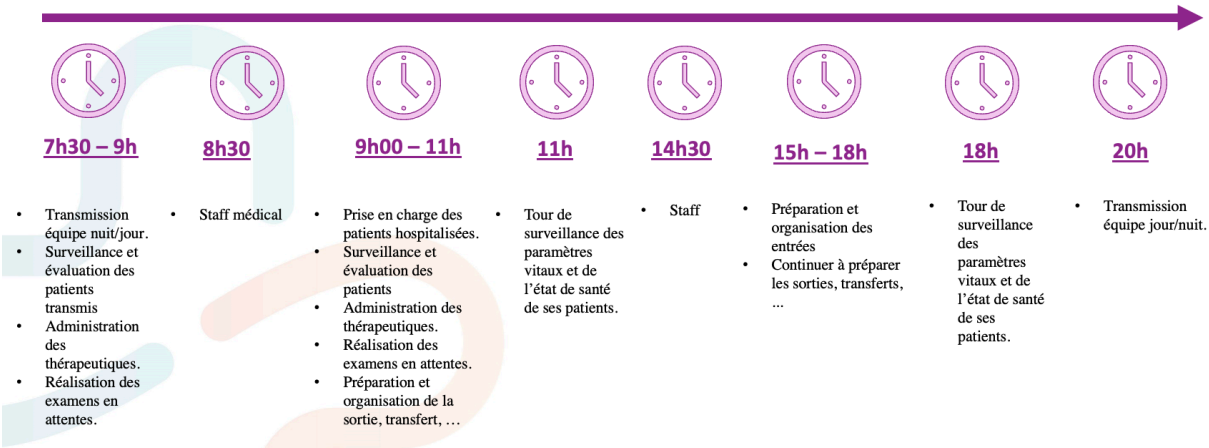
Il est important d'avoir conscience qu'il est difficile de définir une journée type dans un service d'urgences. En effet, le rythme est dicté par le flux des patients (entrées et sorties), mais aussi par l'évolution de leur état de santé, qui peut se dégrader à tout moment au cours de la prise en charge.

Cependant, certains moments clés jalonnent la journée et doivent être rigoureusement respectés afin d'assurer une bonne organisation du service et de garantir la sécurité des patients.



UN EXEMPLE DE JOURNEE TYPE AUX LITS D'URGENCES

Une journée type dans un service d'hospitalisation commence généralement tôt le matin avec la transmission entre les équipes. C'est le moment où l'équipe de nuit informe l'équipe du matin sur l'état des patients, les incidents survenus, et les besoins spécifiques à prendre en compte. Cette étape permet une bonne continuité des soins et une mise à jour du dossier patient.



Mes livrets d'accueil

Tome 1 - La fondation et l'hôpital

Tome 2 – Le service des urgences

Tome 3 – Mon intégration

Tome 4 – Mon plan de formation et le développement de mes compétences

Tome 5 – Mes outils du quotidien

Tome 6 – Les logiciels Ressources Humaines

Tome 7 – Les logiciels métiers

Tome 8 – Les procédures et protocoles du service et de l'institution

Tome 9 – Situation sanitaire exceptionnelle

Les livrets spécifiques

Tome 10 – La Salle d'Accueil des Urgences Vitale (SAUV)

Tome 11 – L'Infirmier Organisateur de l'Accueil (IOA)